

Câncer do colo · rastreio e condutas

Quase todo câncer cervical liga-se ao HPV. Rastreio com citologia/HPV detecta pré-malignos; vacina previne. Lesão invasiva muda para estadiamento e tratamento oncológico.

Rastreio (conceito MS)

Dica - Rastreio (conceito MS)

Citologia de 25–64 anos, após dois anuais normais !' a cada 3 anos. Teste de HPV entra em protocolos atualizados — siga a banca/MS vigente.

Décadas de janela: rastreio intercepta NIC antes da invasão.



Condutas high-yield

- ASC-US/LSIL: repetir ou tipagem HPV conforme fluxo etário
- HSIL/ASC-H/AGC: colposcopia; tratar NIC 2/3 (excisão)
- Invasivo inicial: cirurgia (conização/histerectomia radical conforme estágio)
- Localmente avançado: radio + quimio (cisplatina) clássica

Sinais de invasão

Achado | Nota

Sangramento de contato | Pós-coito clássico

Corrimento fétido | Tumor avançado

Dor pélvica / linfedema | Doença avançada

Citologia com células invasivas | Referência oncológica

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Gestante com citologia alterada: colposcopia é segura; evita-se excisão desnecessária no 1ºT sem invasão. Vacina HPV não trata infecção já estabelecida — previne.